

Saúde mental e envelhecimento

RODRIGO NICOLATO
JUSSARA ALVARENGA

Este capítulo pretende discutir as possíveis consequências neuropsicológicas dos quadros psiquiátricos, sobretudo afetivos e psicóticos, nos pacientes acima de 60 anos, sejam instalados de forma precoce ou tardia. Os transtornos psiquiátricos que se iniciam em pacientes quando jovens seriam mais graves, em termos de comprometimento cognitivo, que quadros iniciados tardiamente? Ou os quadros tardios seriam manifestações precoces de quadros demenciais? Tais quadros, possivelmente em virtude de alterações de neurodesenvolvimento ou neurodegeneração, comprometem, de fato, a cognição, ou seria simplesmente o efeito do envelhecimento sobre esses quadros que levaria a um prejuízo cognitivo? Os pacientes com depressão tardia, psicose tardia e transtorno bipolar tardio apresentariam maior possibilidade de evoluir para quadros demenciais? E os fatores neurobiológicos, como aspectos da neurotransmissão no idoso, poderiam também particularizar determinadas apresentações neuropsicológicas?

TRANSTORNOS AFETIVOS E ENVELHECIMENTO

Transtornos do humor, ou afetivos, compreendem quadros unipolares, como a depressão maior e a disti-

mia (quadro depressivo leve, crônico e com duração acima de dois anos), e quadros bipolares, que abrangem o transtorno bipolar tipo I, em que há ao menos um episódio de mania ou episódio misto, e o transtorno bipolar tipo II, em que há ao menos um episódio de hipomania. Tanto no caso de transtorno bipolar tipo I quanto no tipo II, há grande possibilidade da presença de episódios de depressão, que seriam episódios de depressão bipolar.

Depressão

O termo depressão tem, atualmente, vários usos: o primeiro refere-se à tristeza e é usado por leigos, nem sempre estando associado a uma doença; o segundo é quando se fala do sintoma "depressão", que pode estar presente nas mais diversas patologias mentais, como demências, alcoolismo e esquizofrenia. Ainda há o uso para definir uma síndrome, que, além da alteração do humor, apresenta alterações cognitivas, psicomotoras e vegetativas, e, por último, a doença depressão, que tem diversas classificações, como transtorno depressivo maior, distímia, depressão como parte do transtorno bipolar ou como parte da ciclotimia.

Déficits cognitivos constituem uma característica importante do quadro de depressão maior, sobretudo em áreas como atenção, memória e velocidade psicomotora (conforme aponta estudo de Beckman, 1999).

Déficits cognitivos constituem uma característica importante do qua-

Déficits cognitivos constituem uma característica importante do quadro de depressão maior, sobretudo em áreas como atenção, memória e velocidade psicomotora (conforme aponta estudo de Beckman, 1999).

dro de depressão maior, sobretudo em áreas como atenção, memória e velocidade psicomotora (conforme aponta estudo de Beckman, 1999). Esse estudo indicou a seguinte prevalência de depressão em idosos na comunidade: 1,8% para depressão maior; 9,8% para depressão menor; e 13,5% para sintomatologia depressiva clinicamente significativa. Esta última consiste em sintomas depressivos subsindrômicos, que podem ser fatores de risco para desenvolvimento de quadros de depressão maior e agravamento de síndromes clínicas, como as cardiovasculares, e que devem ser acompanhados, a fim de que se observe a necessidade de tratamento específico.

Especula-se que os quadros depressivos nos idosos sejam preferencialmente atípicos, ditos menores, como a distímia, ou quadros depressivos com um número menor de sintomas que a depressão maior e diferentes em relação aos apresentados por indivíduos mais jovens. Existe necessidade de se adequar os critérios diagnósticos de depressão de adultos para idosos, pois até este momento não há critérios diagnósticos específicos para depressão ou qualquer outro quadro no idoso. Barcelos-Ferreira e colaboradores (2009), em uma amostra de 15.491 idosos, observaram prevalência de 7% para depressão maior, 26% para sintomatologia depressiva e 3,3% para distímia. A sintomatologia depressiva podia indicar depressão maior, distímia e quadros menores e até transtorno de ajustamento, reforçando a importância dos quadros subsindrômicos na saúde clínica do idoso.

Os sintomas depressivos são geralmente investigados por meio de rastreamento por escalas de depressão.

Por meio da escala GHQ-12, em um estudo com idosos em Minas Gerais, Cas-

tro-Costa, Lima-Costa, Carvalhais, Fírmio e Uchoa (2008) encontraram prevalência de 38,5% de sintomas depressivos em idosos, com os seguintes fatores associados: sexo feminino, idade acima de 80 anos, baixa escolaridade, ser solteiro, estado civil separado, insônia, diminuição de atividades da vida diária e autorrelato de saúde ruim. Barcelos-Ferreira e colaboradores (2009), em estudo de 2009, encontraram sexo feminino, episódio depressivo prévio, comprometimento cognitivo funcional, sedentarismo e uso de psicotrópicos como fatores associados à prevalência de 13% de sintomas depressivos, aferidos por meio da escala D-10.

O termo depressão subsindrômica se aplica aos idosos com sintomas clinicamente significativos de depressão, mas que não preenchem critérios para depressão maior, podendo englobar distímia, depressão menor e depressão sublimiar, sendo que a depressão menor reuniria os mesmos sintomas da depressão maior, mas com critérios diagnósticos entre 2 e 5 sintomas, ao passo que a depressão maior se apresenta com pelo menos 5 sintomas. A depressão menor apresentaria também menor gravidade em relação ao quadro de depressão maior. Os conceitos de depressão menor e subsindrômica não são oficialmente aceitos, embora se presuma que haja maior morbidade em idosos com depressão subsindrômica em relação àqueles sem sintomas depressivos

(American Psychiatric Association [APA], 1995).

Geralmente, o quadro de depressão em idosos cursa com queixas somáticas inespecíficas, sintomas ansiosos, sensação de desamparo e desesperança, preocupações excessivas, queixas de memória, lentificação motora e irritabilidade (Gallo & Rabins, 1999).

Geralmente, o quadro de depressão em idosos cursa com queixas somáticas inespecíficas, sintomas ansiosos, sensação de desamparo e desesperança, preocupações excessivas, queixas de memória, lentificação motora e irritabilidade (Gallo & Rabins, 1999).

cessivas, queixas de memória, lentificação motora e irritabilidade (Gallo & Rabins, 1999).

Embora não haja certeza quanto às diferenças diagnósticas entre a depressão de início tardio e aquela de início precoce, a depressão tardia pode cursar com alteração cognitiva importante, alterações na substância branca observadas com ressonância magnética nuclear (RMN) (hiperintensidade) e menor história familiar de quadros depressivos. A depressão tardia se associa a comprometimento clínico, e a de início precoce, a comorbidade psiquiátrica (Alexopoulos, 2005; Schweitzer, Tuckwell, O'Brien, & Ames, 2002). Durante a avaliação de um paciente com sintomas depressivos, devem-se considerar as diversas causas possíveis para o quadro, como uso de medicamentos, tais como anti-hipertensivos (propranolol, clonidina), antiparkinsonianos, corticosteroides, entre outros, bem como a presença de determinadas patologias, como doenças endócrinas (hipotireoidismo), neurológicas, nutricionais, infecciosas e neoplasias.

A depressão é o transtorno psiquiátrico mais prevalente em hospitais gerais e em interconsultas psiquiátricas, abrangendo de 20 a 33% dos pacientes internados.

É muito provável que pacientes com patologias clínico-cirúrgicas apresentem mais quadros depressivos em relação a controles sem doenças clínicas. Frequentemente, os casos de depressão são subdiagnosticados e subtratados. A depressão pode ser predisposta por doenças crônicas e pode agravar a situação clínica de muitos pacientes. A relação entre depressão e coronariopatia é muito estudada e bilateral: pacientes coronariopatas que apresentam depressão no pós-infarto agudo do miocárdio têm maior mortalidade em relação àqueles sem depressão que sofrem infarto, e pacientes deprimidos têm maior possibilidade de apresentar coronariopatia (Nicolato, Corrêa, Romano-Silva, & Teixeira,

2006a). A relação entre depressão e doenças clínico-cirúrgicas pode contemplar as seguintes situações, segundo Nicolato e Silveira (2006b):

- A depressão pode, pela existência de sintomas físicos (insônia, dor, alteração de apetite e do peso, desânimo), mimetizar doenças clínico-cirúrgicas, embora os sintomas físicos da depressão sejam objeto de estudos que denotam a presença real de sintomas não cognitivos, como os algícos.
- Sintomas físicos de doenças clínico-cirúrgicas podem mimetizar quadros depressivos.
- A depressão com predomínio de sintomas físicos pode não ser reconhecida, sendo a sintomatologia física justificada pelas doenças clínico-cirúrgicas.
- Pode haver simplesmente uma coincidência: presença de depressão e de doença clínico-cirúrgica.
- A depressão pode ser secundária à doença clínico-cirúrgica e ao uso de medicamentos ou drogas.
- A depressão pode agravar ou desencadear doenças clínico-cirúrgicas.
- Doenças clínico-cirúrgicas podem desencadear quadros depressivos.
- A sintomatologia depressiva pode não ser suficiente para caracterizar uma depressão maior, sendo desencadeada pelas dificuldades e tensões provocadas pelo diagnóstico de uma doença clínico-cirúrgica, como no transtorno de ajustamento com sintomas depressivos, um quadro mais brando e fronteiro entre depressão e normalidade.

Na segunda metade da década de 1990, o conceito de depressão vascular co-

A depressão é o transtorno psiquiátrico mais prevalente em hospitais gerais e em interconsultas psiquiátricas, abrangendo de 20 a 33% dos pacientes internados.

meçou a ser muito difundido, sobretudo a partir dos estudos de Alexopoulos e colaboradores (1997), nos quais se observou que o quadro de depressão em idosos cursa com maior gravidade de alteração isquêmica subcortical silenciosa (à RMN) e com lesões hiperintensas, que, embora possam ocorrer durante o envelhecimento normal, seriam mais frequentes em idosos deprimidos, sendo, possivelmente, fator de risco para depressão de início tardio.

Quanto aos quadros depressivos, depressão maior é um fator de risco para demência vascular (Lenoir et al., 2011) e doença de Alzheimer (DA) (Saczynski et al., 2010), o que torna fundamental que se aumente a atenção para a possibilidade de que quadros depressivos tardios sejam manifestações prodrômicas de demência ou que aspectos neuroquímicos sejam o elo entre depressão tardia e demência, reforçando a necessidade de verificar a possibilidade de progres-

QUADRO 6.1 • Critérios para Episódio de Depressão Maior, segundo o DSM-IV-TR

Critérios para Episódio Depressivo Maior

- A. No mínimo cinco dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma alteração a partir do funcionamento anterior; pelo menos um dos sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda do interesse ou prazer.

Nota: Não incluir sintomas nitidamente devidos a uma condição médica geral ou alucinações ou delírios incongruentes com o humor.

- (1) humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por relato subjetivo (p. ex., sente-se triste ou vazio) ou observação feita por terceiros (p. ex., chora muito). **Nota:** Em crianças e adolescentes, pode ser humor irritável.
 - (2) acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias (indicado por relato subjetivo ou observação feita por terceiros)
 - (3) perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta (p. ex., mais de 5% do peso corporal em 1 mês), ou diminuição ou aumento do apetite quase todos os dias. **Nota:** Em crianças, considerar incapacidade de apresentar os ganhos de peso esperados
 - (4) insônia ou hipersonia quase todos os dias
 - (5) agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias (observáveis por outros, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento)
 - (6) fadiga ou perda de energia quase todos os dias
 - (7) sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada (que pode ser delirante), quase todos os dias (não meramente auto-recriminação ou culpa por estar doente)
 - (8) capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão, quase todos os dias (por relato subjetivo ou observação feita por outros)
 - (9) pensamentos de morte recorrentes (não apenas medo de morrer), ideação suicida recorrente sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio
- B. Os sintomas não satisfazem os critérios para um Episódio Misto.
- C. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.
- D. Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância (p. ex., droga de abuso ou medicamento) ou de uma condição médica geral (p. ex., hipotireoidismo).
- E. Os sintomas não são mais bem explicados por Luto, ou seja, após a perda de um ente querido, os sintomas persistem por mais de 2 meses ou são caracterizados por acentuado prejuízo funcional, preocupação mórbida com desvalia, ideação suicida, sintomas psicóticos ou retardo psicomotor.

Fonte: APA (1995).

são da depressão para demência por meio de avaliações neuropsicológicas frequentes, e desconstrói, em parte, o antigo conceito de pseudodemência.

Para Dotson, Beydoun e Zonderman (2010), o número de episódios aumenta a possibilidade de progressão para demência, o que reforça a necessidade de tratamento adequado para tentar reduzir esse fator de risco.

Segundo Vilalta-Franch e colaboradores (2012), em muitos pacientes, o quadro de depressão maior cursa com alterações neuropsicológicas compatíveis com comprometimento do lobo frontal, medidas por desempenho inferior em pensamento abstrato, teste do relógio, fluência verbal semântica e atenção, aferidos pela Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly (CAMDEX). Além disso, pacientes deprimidos idosos com alterações frontais apresentam maior possibilidade de evoluir para quadros demenciais e requerem melhor acompanhamento clínico e neuropsicológico. Em estudo longitudinal de três anos, pacientes deprimidos com sintomas demenciais aparentemente reversíveis desenvolveram demência irreversível, sendo que o risco de desenvolvê-la foi, entre aqueles com depressão e demência reversível, quase cinco vezes maior que entre aqueles que tinham depressão sem sintomas cognitivos demenciais (Alexopoulos et al., 2002), justificando a necessidade de avaliações sequenciais, sobretudo em idosos com alterações cognitivas importantes.

Transtorno bipolar

O transtorno bipolar (TB) é atualmente considerado uma patologia espectral, podendo o paciente apresentar episódios de mania,

hipomania e depressão, que pode ir de leve a grave. Basta que haja um episódio de mania, hipomania ou episódio misto (situação em que há a presença de sintomas depressivos e maniformes concomitantemente, com pior prognóstico e a necessidade de se retirar os antidepressivos) para que se considere o diagnóstico de TB. Nos pacientes com mania ou hipomania, há aumento da atividade dirigida para vários setores, como fala e pensamento acelerados, possibilidade de envolvimento com jogos de azar, direção de veículos em velocidade exagerada, gastos excessivos. O termo mania é utilizado de forma equivocada por pessoas leigas, como referência a aspectos patológicos do impulso e até obsessivo-compulsivos, como tricotilomania, obsessão e compulsão por limpeza.

O TB divide-se em três subtipos:

- transtorno bipolar I, que é caracterizado por pelo menos um episódio maníaco ou misto;
- transtorno bipolar II, no qual deve haver pelo menos um episódio hipomaniaco, associado à não existência de episódios maníacos ou mistos;
- transtorno bipolar III, no qual se enquadram os pacientes que viram para mania quando tratados para depressão ou que têm um parente de primeiro grau (pai, mãe, irmãos, filhos) com transtorno bipolar em tratamento para depressão.

Em muitos casos de TB, os pacientes demonstram um primeiro episódio depressivo antes de apresentarem episódio de mania ou hipomania. Percebe-se, com isso, a importância de, ao prescrever antidepressivos, o médico avaliar a história familiar e, se positiva, ficar atento para o caso de uma virada para o polo de mania, risco existente quando do uso de antidepressivos.

Em muitos casos de TB, os pacientes demonstram um primeiro episódio depressivo antes de apresentarem episódio de mania ou hipomania. Percebe-se, com isso, a importância de, ao prescrever antidepressivos, o médico avaliar a história familiar e, se po-

sitiva, ficar atento para o caso de uma virada para o polo de mania, risco existente quando do uso de antidepressivos.

Nos casos de TB, mesmo naqueles de depressão bipolar, os pacientes não podem usar, de forma alguma, antidepressivos isolados dos estabilizadores do humor, como o carbonato de lítio. Em geral, os casos de TB são tarefa do médico psiquiatra. Contudo, em virtude da possibilidade de os pacientes com esse transtorno apresentarem comorbidades clínicas como quaisquer pacientes, frequentemente esses profissionais atenderão pacientes bipolares com cardiopatias, pneumopatias e outras condições clínicas. Em hipótese alguma pacientes com transtornos do humor ou outras patologias psiquiátricas deverão ter o exame clínico negligenciado.

No caso do TB II, apesar de ser uma forma clínica mais branda, é a que envolve maior risco de os pacientes tornarem-se cicladores rápidos, isto é, terem mais de três crises de mania ou hipomania por ano.

Diferentemente de estudos anteriores, em que se reportava prevalência muito reduzida de idosos com TB, o *National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions* (NESARC), em amostra de mais de 8 mil idosos norte-americanos, encontrou prevalência de 1,1% de TB I em pessoas com mais de 64 anos (Godstein, Herrmann, & Schulman, 2006). Os déficits neuropsicológicos são associados ao TB em diversas faixas etárias, mesmo em eutímia, segundo estudo de Murphy e Sanakian (2001). Para Gildergers e colaboradores (2004), a maioria dos idosos eutímicos pode exibir comprometimento cognitivo. Nessa faixa etária, é preciso avaliar o peso de quadros neurológicos e clínicos superpostos ao TB, como hipotireoidismo, hipertensão arterial sistêmica, deficiências vitamínicas e diabetes, que também podem comprometer a cognição. De acordo com Bellivier e colaborado-

res (2003) e Wylie e colaboradores (1999), há de se ressaltar a possibilidade de que subtipos específicos, gravidade do quadro, escolaridade, cronicidade e idade de início precoce do quadro colaborem para o comprometimento cognitivo.

Em estudo de Tsai, Lee, Chen e Huang (2007), com 52 idosos eutímicos, em que se definiu como TB de início precoce a condição dos idosos que apresentaram o início do transtorno antes dos 40 anos, a cognição foi avaliada por meio do Teste do Relógio (de 0 a 5 pontos, segundo Shulman, 2000). Quase 50% dos pacientes exibiram alterações nesse teste ou no Miniexame do Estado Mental (MEEM), já analisados os fatores relacionados à escolaridade, sobretudo nos pacientes com alterações cardiovasculares.

Em outro estudo (Huang et al., 2012), a maioria dos idosos com TB havia tido infartos cerebrais silenciosos, talvez por problemas metabólicos e cardiovasculares não investigados, que podem colaborar para possível comprometimento cognitivo.

Compararam-se pacientes com início tardio do TB a pacientes com início precoce: o giro do cíngulo posterior direito, o núcleo caudado esquerdo e o giro frontal médio esquerdo de pacientes com TB de início tardio eram maiores, mediante ressonância magnética do encéfalo, em relação aos de pacientes idosos com TB de início precoce. Isso alimenta a hipótese de que o TB que se inicia após os 40 ou 50 anos constitui outro quadro, devido a comprometimento cerebral funcional, embora a instalação tardia do TB não seja necessariamente acompanhada pela presença de fatores cerebrovasculares, pois, conforme já apontado, há estudos que afirmam que o TB de instalação precoce, ou antes dos 40 ou 50 anos, seja associado ao envelhecimento patológico, como à presença de doenças clínicas e/ou neurológicas.

Para Laks (2009), inúmeras diferenças clínicas são apresentadas no TB de idosos em comparação ao de jovens:

- A relação entre mulheres-homens aumenta de 1/1,5 para 2/3, denotando que entre idosos bipolares há predomínio de mulheres acometidas em relação a homens.
- O período de latência entre o primeiro episódio de depressão e o primeiro de mania é mais longo em pacientes idosos do que em jovens (17 e 3 anos, respectivamente).
- Os pacientes idosos estão mais propensos que os jovens a manifestar episódios depressivos após episódio de mania.
- Os sintomas psicóticos podem ser mais refratários em idosos do que em jovens.
- O envelhecimento está mais associado a episódios mais longos e intervalos menores entre os episódios, e há mais recorrência de casos de mania diagnosticados em idosos.
- Quando comparado com o episódio de mania em pacientes jovens, no idoso, o quadro é caracterizado por sintomas de menor intensidade, mas mais frequentemente com irritabilidade, hostilidade e sintomas mistos.
- O retardo psicomotor é uma das características do TB em idosos.
- A mortalidade é maior nos pacientes idosos com TB do que na população normal, não apenas por associação com doenças clínicas, mas também por fatores inerentes ao próprio transtorno.
- O curso clínico do TB em idosos não é bem delimitado, mas somente pequena parte evolui com recuperação clínica sig-

QUADRO 6.2 • Critérios diagnósticos para episódio maníaco, segundo o DSM-IV-TR

- A. Um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, com duração mínima de 1 semana (ou qualquer duração, se a hospitalização se fizer necessária).
- B. Durante o período de perturbação do humor, três (ou mais) dos seguintes sintomas persistiram (quatro, se o humor é apenas irritável) e estiveram presentes em um grau significativo:
 - (1) autoestima inflada ou grandiosidade
 - (2) redução da necessidade de sono (p. ex., sente-se refeito depois de apenas 3 horas de sono)
 - (3) mais loquaz do que o habitual ou pressão por falar
 - (4) fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão correndo
 - (5) distratibilidade (i. é, a atenção é desviada com excessiva facilidade por estímulos externos insignificantes ou irrelevantes)
 - (6) aumento da atividade dirigida a objetivos (socialmente, no trabalho, na escola ou sexualmente) ou agitação psicomotora
 - (7) envolvimento excessivo em atividades prazerosas com um alto potencial para consequências dolorosas (p. ex., envolvimento em surtos incontidos de compras, indiscrições sexuais ou investimentos financeiros insensatos)
- C. Os sintomas não satisfazem os critérios para Episódio Misto.
- D. A perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento ocupacional, nas atividades sociais ou relacionamentos costumeiros com outros, ou de exigir a hospitalização, como um meio de evitar danos a si mesmo e a terceiros, ou existem características psicóticas.
- E. Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância (p. ex., uma droga de abuso, um medicamento ou outro tratamento) ou de uma condição médica geral (p. ex., hipertireoidismo).

Nota: Episódios do tipo maníaco nitidamente causados por um tratamento antidepressivo somático (p. ex., medicamentos, terapia eletroconvulsiva, fototerapia) não devem contar para um diagnóstico de Transtorno Bipolar I.

Fonte: APA (1995).

nificativa, e muitos apresentam episódios recorrentes.

Há muitos estudos e muitas afirmações controversas que chegam a associar a mania em idosos à etiologia orgânica, quase inexoravelmente. Se tal associação fosse tão evidente, o quadro de mania em idosos seria muito mais frequente, conforme informam os estudos de Almeida e Fenner (2002), desfazendo a noção da forte associação da ocorrência de mania em idosos, sobretudo com doenças cerebrovasculares, que, por sua vez, se associam com muito mais evidência à depressão.

De qualquer forma, as doenças clínico-neurológicas, que não se propagam de maneira tão comum, podem se associar à

ocorrência de TB em idosos. E, segundo Almeida e Fenner (2002), podem ser:

- doenças cerebrovasculares – associação relativamente pouco significativa;
- demências (Alzheimer, frontotemporal, vascular);
- lesão cerebral traumática, epilepsia, tumores cerebrais, neurosífilis, encefalite, neurocisticercose;
- deficiência de vitamina B12;
- hipertireoidismo;
- síndrome de Cushing;
- uso de corticoides;
- uso de antidepressivos levando à virada para mania (mas os pacientes bipolares têm maiores possibilidades de apresentar virada).

QUADRO 6.3 • Critérios diagnósticos para episódio hipomaniaco, segundo o DSM-IV-TR

- A. Um período distinto de humor persistentemente elevado, expansivo ou irritável, durando todo o tempo ao longo de um período mínimo de 4 dias, nitidamente diferente do humor habitual não deprimido.
- B. Durante o período da perturbação do humor, três (ou mais) dos seguintes sintomas persistiram (quatro se o humor for apenas irritável) e estiveram presentes em um grau significativo:
 - (1) autoestima ou grandiosidade
 - (2) redução da necessidade de sono (p. ex., sente-se refeito depois de apenas 3 horas de sono)
 - (3) mais loquaz do que o habitual ou pressão por falar
 - (4) fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão correndo
 - (5) distratibilidade (i. é, a atenção é desviada com demasiada facilidade por estímulos externos insignificantes ou irrelevantes)
 - (6) aumento da atividade dirigida a objetivos (socialmente, no trabalho, na escola ou sexualmente) ou agitação psicomotora
 - (7) envolvimento excessivo em atividades prazerosas com alto potencial para consequências dolorosas (p. ex., envolver-se em surtos desenfreados de compras, indiscrições sexuais ou investimentos financeiros insensatos)
- C. O episódio está associado com uma inequívoca alteração no funcionamento, que não é característica do indivíduo quando assintomático.
- D. A perturbação do humor e a alteração no funcionamento são observáveis por terceiros.
- E. O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou ocupacional, ou de exigir hospitalização, nem existem características psicóticas.
- F. Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância (p. ex., droga de abuso, medicamento, ou outro tratamento) ou de uma condição médica geral (p. ex., hipertireoidismo).

Nota: Os episódios do tipo hipomaniaco nitidamente causados por um tratamento antidepressivo somático (p. ex., medicamentos, terapia eletroconvulsiva e fototerapia) não devem contar para um diagnóstico de Transtorno Bipolar II.

Fonte: APA (1995).

Esses quadros clínicos podem se associar à ocorrência de TB, bem como podem ser diagnóstico diferencial desse transtorno. Mesmo que não se possa considerar, em hipótese alguma, que todos os casos de TB tardios sejam secundários a doenças clínico-neurológicas, convém descartar a presença desses quadros por meio de exames de neuroimagem, exames bioquímicos e neuropsicológicos.

Os idosos bipolares apresentam um grau intenso de morbidade, sua resposta aos psicofármacos é mais pobre, além do já descrito comprometimento funcional global, sendo necessários mais estudos para melhor caracterização do quadro (Benedetti et al., 2008). Em estudo com 57 pacientes bipolares idosos, realizado na Universidade de São Paulo (USP), a eutímia foi observada em quase 70% do tempo (sete anos de análise); a depressão, em 20%; a euforia, em 10%; e o quadro misto foi raro (1%) (Nunes, Paganelli, & Forlenza, 2007). Os idosos bipolares possivelmente podem evoluir para demência em proporção maior (duas vezes) em relação aos pacientes com outras doenças crônicas (Kessing & Nilsson, 2003). Idosos bipolares eutímicos apresentam mais sintomas extrapiramidais, lentificação psicomotora, comprometimento de memória verbal e de funções executivas em relação a pacientes idosos sem TB (Martino et al., 2008), denotando que mesmo os eutímicos podem cursar com deterioração cognitiva.

QUADROS PSICÓTICOS E ENVELHECIMENTO

Kraepelin, além de outras contribuições expressivas, como os conceitos de demência precoce (esquizofrenia, a partir de Eugen Bleuler) e psicose maníaco-depressiva – na primeira condição haveria deteriora-

ção mental, e, na segunda, não haveria prejuízo funcional entre as crises –, descreveu a paranoia (transtorno delirante), em que os delírios seriam mais plausíveis e não haveria deterioração, e parafrenia, um quadro com delírios e alucinações, com instalação mais tardia e sem comprometimento mental importante (Berrios, 2003). Embora o legado de demência precoce apontasse para uma condição neurodegenerativa, há estudiosos que indicam alterações na esquizofrenia mais voltadas para o comprometimento do neurodesenvolvimento que necessariamente de neurodegeneração, como aponta o estudo de Heyman e Murray (1992). Posteriormente, Bleuler (1978) observou quadros de esquizofrenia surgidos mais tardiamente e subdividiu-a em es-

Os idosos bipolares possivelmente podem evoluir para demência em proporção maior (duas vezes) em relação aos pacientes com outras doenças crônicas (Kessing & Nilsson).

qu岸ofrenia de início tardio, instalada a partir dos 40 anos, e esquizofrenia de início precoce, iniciada antes dos 40 anos, sem que se observassem diferenças entre as apresenta-

ções que acometiam os pacientes mais novos ou os mais velhos. Almeida e colaboradores (1995) dividiram a psicose de instalação tardia em dois grupos:

- tipo A, caracterizada por sintomas psicóticos mais floridos, sinais e sintomas cognitivos compatíveis apenas com alterações frontais, alguns poucos sintomas e sinais neurológicos, e
- tipo B, caracterizada por sintomas psicóticos menos floridos, maior presença de sinais neurológicos e comprometimento cognitivo generalizado.

Embora as alterações cognitivas possam se sobrepor à psicose, seja a de início tardio ou a precoce, há muitas dúvidas acerca das alterações neuropsicológicas associadas à psicose no idoso.

QUADRO 6.4 • Critérios diagnósticos para esquizofrenia, segundo o DSM-IV-TR

A. *Sintomas característicos*: No mínimo dois dos seguintes quesitos, cada qual presente por uma porção significativa de tempo durante o período de 1 mês (ou menos, se tratados com sucesso):

- (1) delírios
- (2) alucinações
- (3) discurso desorganizado (p. ex., frequente descarrilamento ou incoerência)
- (4) comportamento amplamente desorganizado ou catatônico
- (5) sintomas negativos, isto é, embotamento afetivo, alogia ou abulia

Nota: Apenas um sintoma do Critério A é necessário quando os delírios são bizarros ou as alucinações consistem em vozes que comentam o comportamento ou os pensamentos da pessoa, ou duas ou mais vozes conversando entre si.

B. *Disfunção social/ocupacional*: Por uma porção significativa do tempo desde o início da perturbação, uma ou mais áreas importantes do funcionamento, tais como trabalho, relações interpessoais ou cuidados pessoais, estão acentuadamente abaixo do nível alcançado antes do início (ou quando o início se dá na infância ou adolescência, incapacidade de atingir o nível esperado de realização interpessoal, acadêmica ou profissional).

C. *Duração*: Sinais contínuos da perturbação persistem pelo período mínimo de 6 meses. Esse período de 6 meses deve incluir pelo menos 1 mês de sintomas (ou menos, se tratados com sucesso) que satisfazem o critério A (i. é, sintomas da fase ativa) e pode incluir períodos de sintomas prodrômicos ou residuais. Durante esses períodos prodrômicos ou residuais, os sinais da perturbação podem ser manifestados apenas por sintomas negativos ou por dois ou mais sintomas relacionados no Critério A presentes de uma forma atenuada (p. ex., crenças estranhas, experiências perceptuais incomuns).

D. *Exclusão de Transtorno Esquizaofetivo e Transtorno do Humor*. O Transtorno Esquizaofetivo e o Transtorno do Humor com Características Psicóticas foram descartados, porque (1) nenhum Episódio Depressivo Maior, Maníaco ou Misto ocorreu concomitantemente aos sintomas da fase ativa; ou (2) se os episódios de humor ocorreram durante os sintomas da fase ativa, sua duração total foi breve com relação à duração dos períodos ativo e residual.

E. *Exclusão de substância/condição médica geral*: A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância (p. ex., uma droga de abuso, um medicamento) ou a uma condição médica geral.

F. *Relação com um Transtorno Global do Desenvolvimento*: Se existe um histórico de Transtorno Autista ou de outro Transtorno Global do Desenvolvimento, o diagnóstico adicional de Esquizofrenia é feito apenas se delírios ou alucinações proeminentes também estão presentes pelo período mínimo de 1 mês (ou menos, se tratados com sucesso).

Classificação do curso longitudinal (pode ser aplicada apenas 1 ano após o aparecimento inicial dos sintomas da fase ativa):

Episódico Com Sintomas Residuais Entre o Episódios (os episódios são definidos pelo ressurgimento de sintomas psicóticos proeminentes); *especificar também se*: **Com Predomínio de Sintomas Negativos**

Episódico Sem Sintomas Residuais Entre os Episódios

Contínuo (sintomas psicóticos proeminentes estão presentes durante todo o período de observação); *especificar também se*: **Com Predomínio de Sintomas Negativos**

Episódio Único em Remissão Parcial; *especificar também se*: **Com Predomínio de Sintomas Negativos**

Episódio Único em Remissão Completa

Outro Padrão ou Padrão Inespecificado

Fonte: APA (1995).

Em 1997, Mocker, Riordan e Sharma (1997) identificaram, por meio da Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised (WAIS-R), do National Adult Reading Test (NART) e do Rivermead Behavioural Memory Test, a ausência de deterioração cognitiva associada com a faixa etária. Harvey (2001) observou, ao longo de 30 meses, que indivíduos com esquizofrenia crônica cursam com comprometimento da cognição e que esse declínio não é o mesmo da DA e nem do comprometimento cognitivo possivelmente associado ao envelhecimento. Em 1999, Sachdev, Brodaty, Rose e Cathcart estudaram três grupos de indivíduos: com esquizofrenia de início tardio, com esquizofrenia de início precoce e voluntários saudáveis. Os pacientes psicóticos cursaram com prejuízo em funções executivas e em testes de memória em relação aos indivíduos saudáveis, mas entre os grupos de pacientes psicóticos, seja de início precoce ou tardio, não houve diferenças. O estudo de Palmer e colaboradores (2003), avançou mais ainda, na tentativa de elucidar as diferenças neuropsicológicas de cinco grupos: pacientes com esquizofrenia e demais psicoses de início tardio (37 pacientes que desenvolveram quadro psicótico após os 45 anos); pacientes com esquizofrenia e outras psicoses de início precoce (69 pacientes que desenvolveram quadro psicótico com menos de 45 anos); pacientes com DA com psicose (67 pacientes); pacientes com DA com declínio cognitivo leve (72 pacientes com resultado no MEEM maior ou igual a 24 pontos); e 56 voluntários sadios, não encontrando variações no desempenho neuropsicológico avaliado por meio da Escala Mattis e do MEEM. Os resultados permitiram encontrar semelhanças neuropsicológicas entre o grupo de psicóticos e o de voluntários, independentemente da diferença quanto à instalação tardia ou precoce e diferentemente do grupo de pacientes com demên-

cia, reforçando que as alterações neuropsicológicas dos pacientes com esquizofrenia são estáticas e diferentes da neurodegeneração demencial.

Em revisão de literatura de Lagodka e Robert (2009), evidenciou-se que a psicose tardia e a psicose instalada muito tardiamente (acima de 60 anos) não são diferentes em termos neuropsicológicos. A psicose tardia cursa com mais alteração em memória de curto prazo, e a DA, com mais alteração na evocação tardia. Uma parte dos pacientes com psicose tardia cursou com maior possibilidade de evoluir para demência, ao longo de um período de observação de 10 anos, em relação aos pacientes com psicose de início precoce, permitindo o questionamento, embora com divergências, de que uma pequena parte dos pacientes com psicose tardia não poderia ser um pródromo de demência.

Convém mencionar o fato de que os quadros psicóticos podem ser associados a inúmeras condições médicas gerais, como hipertireoidismo e demência, e outras condições clínicas e neurológicas. Nicolato e colaboradores (2006c) apresentaram uma série de casos em que idosos (sobretudo do sexo feminino) cursavam com delírio somático de parasitose (síndrome de Ekbom) associado a doenças clínicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda há muito para se estudar acerca da associação entre quadros psiquiátricos e envelhecimento. Estudos prospectivos com idosos sadios em comparação a grupos de jovens, adultos mais velhos e idosos com quadros afetivos e psicóticos, além de pacientes com demência, com maior número de indivíduos participantes, são muito importantes para conclusões mais definitivas, utilizando-se exames bioquímico-genéti-

cos, exames neurorradiológicos estruturais, funcionais e neuropsicológicos, além de detalhada história pessoal e familiar.

Os estudos ainda são pouco conclusivos em relação à instalação tardia ou precoce dos quadros afetivos e psicóticos quanto ao comprometimento cognitivo, assim como não há consenso em relação às alterações serem neurodegenerativas ou compatíveis com neurodegeneração ou se ambas as possibilidades existem. Há dúvidas também quanto à associação entre o envelhecimento e os quadros psiquiátricos, mas deve-se repensar a noção de que esses quadros seriam apenas funcionais, podendo representar fatores de risco para quadros demenciais ou mesmo manifestação prodromica de quadros demenciais, ao menos em algumas situações. Também são necessários mais estudos para identificar quais pacientes com quadros psiquiátricos seriam mais vulneráveis a ter envelhecimento patológico em termos cognitivos e se tratamento precoce pode ser importante para reduzir o comprometimento cognitivo.

REFERÊNCIAS

- Alexopoulos, G. S. (2005). Depression in the elderly. *Lancet*, 365(9475), 161-70.
- Alexopoulos, G. S., Borson, S., Cuthbert, B. N., Devanand, D. P., Mulsant, B. H., Olin, J. T., & Olin, D. W. (2002). Assessment of late life depression. *Biological Psychiatry*, 52(3), 164-74.
- Alexopoulos, G. S., Meyers, B. S., Young, R. C., Kakuma, T., Silbersweig, D., & Charlson, M. (1997). Clinically defined vascular depression. *American Journal of Psychiatry*, 154(4), 562-5.
- Almeida, O. P., Fenner, S. (2002). Bipolar disorder: similarities and differences between patients with illness onset before and after 65 years of age. *International Psychogeriatric*, 14(3), 311-22.
- Almeida, O. P., Howard, R. J., Levy, R., David, A. S., Morris, R. G., & Sahakian, B. J. (1995). Clinical and cognitive diversity of psychotic states arising in late life (late paraphrenia). *Psychological Medicine*, 25(4), 699-714.
- Associação Americana de Psiquiatria. (1995). *Manual de diagnóstico e estatística de distúrbios mentais* (DSM IV). Porto Alegre: Artes Médicas.
- Barcelos-Ferreira, R., Pinto, J. A. Jr, Nakano, E. Y., Steffens, D. C., Litvock, J., & Bottino, C. M. (2009). Clinically significant depressive symptoms and associated factors in community elderly subjects from São Paulo, Brazil. *American Journal of Geriatric Psychiatry*, 17(7), 582-90.
- Beekman, A. T., Coperland, J. R., Prince, M. J. (1999). Review of community prevalence of depression in later life. *British Journal of Psychiatry*, 174, 307-11.
- Bellivier, F., Golmard, J. L., Rietschel, M., Schälze, T. G., Malafosse, A., & Preisig, M. (2003). Age at onset in bipolar I affective disorders: further evidence for three subgroups. *American Journal of Psychiatry*, 160(5), 999-1009.
- Benedetti, A., Scarpellini, P., Casamassina, F., Letanzi, L., Liberti, M., Musetti, L., & Cassano, G. A. (2008). Bipolar disorder in late life: clinical characteristics in a sample of older adults admitted for manic episode. *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health*, 4, 22-6.
- Berrios, G. E. (2003). The insanities of the third age: a conceptual history of paraphrenia. *Journal of Nutrition Health and Aging*, 7(6), 349-99.
- Bleuler, M. (1978). *The schizophrenic disorders: long-term patient and family studies*. New Haven: Yale University.
- Castro-Costa, E., Lima-Costa, M. F., Carvalhais, S., Firmino, J. O. A., & Uchoa, E. (2008). Factors associated with depressive symptoms measured by the 12-item general health questionnaire in community-dwelling older adults (The Bambuí health aging study). *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 30(2), 104-9.
- Dotson, V. M., Beydoun, M. A., & Zonderman, A. B. (2010). Recurrent depressive symptoms and the incidence of dementia and mild cognitive impairment. *Neurology*, 75(1), 27-34.
- Gallo, J. J., & Rabins, P. V. (1999). Depression without sadness: alternative presentations of depression in late life. *American Family Physician*, 60(3), 820-6.
- Gildengers, A. G., Butters, M. A., Seligman, K., McShea, M., Miller, M. D., & Mulsant, B. H. (2004). Cognitive functioning in late-life bipolar disorder. *American Journal of Psychiatry*, 161(4), 736-8.